เล่มที่ 1582

แบบส่งกลับ / แบบแจ้งการรักษา

โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

2 ถนนพรานนก บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 โทร.0-2419-7000 เลขที่ 15

วันที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

เรื่อง ขอแจ้งผลการตรวจรักษา

เรียน ผู้อำนวยการโรงพ ทย์ผู้เกี่ยวข้อง

อ้างถึง ผู้ป่วย ชื่อ V ชื่อ นาย พชรพล สุขสำราญ ชาย อายุ 53 ปี

เลขที่บัตรประจำต HN 54-700087 อายุ 53.0.25 15/01/2516 AN

☐ สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า ☐ สิทธิประกันสังคม ☐ สวัสดิการข้าราชการ ☐ อื่น ๆ

โรงพยาบาลศิริราชได้ทำการตรวจรักษาผู้ป่วยรายนี้แล้ว ได้ผลดังนี้

1. การวินิจฉัยโรค Lt substernal goiter

2. ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการและทางรังสีวิทยา

☐ **แนบสำเนา LAB/Patho/.....วันที่.....**

☐ **แนบสำเนา X-Ray.....วันที่.....**

☐ **แนบสำเนา .....วันที่.....**

เหตุผลและความจำเป็น (กรณีการตรวจวินิจฉัยที่มีค่าใช้จ่ายสูง)

3. หัตถการ/การผ่าตัด ☐ **แนบสำเนา.....วันที่.....**

Set OR for total Thyroidectomy

4. MEDICATION ☐ **แนบสำเนา.....วันที่.....**

****หากมียานอกบัญชียาหลักฯ โปรดพิจารณาความเห็นด้านหลัง****

5. ข้อแนะนำในการรักษาต่อไป ☐ **แนบสำเนา.....วันที่.....**

☑ ขอส่งผู้ป่วยให้ท่านดูแลรักษาต่อไป และ

○ ไม่นัดตรวจ ○ ขอนัดมาตรวจ เพื่อติดตามผลการรักษา ในวันที่ นัดผ่าตัด

☐ ผู้ป่วยควรได้รับการทำหัตถการพิเศษ คือ .....

.....ค่าใช้จ่ายประมาณ.....บาท

☐ ผู้ป่วยควรได้รับบริการที่โรงพยาบาลระดับตติยภูมิต่อเนื่อง

☐ ผู้ป่วยยังมีความจำเป็นต้องได้รับบริการที่โรงพยาบาลศิริราชต่อเนื่อง เป็นเวลา.....วัน

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ วชิรปัญ 65324 แพทย์ผู้ตรวจรักษา ภาควิชา ตร.หู คอ จมูก โทร. 02-419-8519

หน่วยตรวจ/หอผู้ป่วย..... โทรศัพท์ .....

(หากประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่องานสิทธิประกันสุขภาพ โทร.0-2419-9936)

Exam Name : CT Chest with contrast **Accession No :** 1179505

CT CHEST ;

HX; Male 52 YO, HT , DLP, lt. thyroid nodule R/O malignancy ..

The axial series CT CHEST were performed in 1.5 mm thickness in pre and post contrast study , lung window.

Due to limitation of the study reveals enlargement lt. thyroid gland with huge mixed cystic -solid inhomogeneous hypodense enhancing lesion with calcification at lt. thyroid , size atlest about 7.6 * 6.0 * 5.9 cm.and pressure effected to the trachea and extened to upper thoracic region .
Multiple nodules at visualized rt. thyroid gland, size upto 0.5 cm.
NO active pulmonary infiltration.
NO pulmonary nodule.
NO pleural effusion.
Small lymphadenopathy at rt. para tracheal region (0.5-0.6 cm), pre carina region region
(0.5-0.6 cm).
NO cardiomegaly.
No peri cardial effusion.
NO endobronchial lesion.
Visualized the liver show normal in size and density without abnormal arterial enhancing lesion.
The GB show multiple GS.
Both adrenal glands appear intact.
Small hypodense at the spleen (0.3cm), likely splenic cyst .
Degenerative change of bony thorax without evidence bony destruction. .

IMP; -Male 52 YO, HT , DLP, lt. thyroid nodule R/O malignancy .
-Due to limitation of the study reveals enlargement lt. thyroid gland with huge mixed cystic -solid inhomogeneous hypodense enhancing lesion with calcification at lt. thyroid , size atlest about 7.6 * 6.0 * 5.9 cm.and pressure effected to the trachea and extened to upper thoracic region ., tissue study is

Exam Name : CT Chest with contrast **Accession No :** 1179505

helpful .

-Multiple nodules at visualized rt. thyroid gland, size upto 0.5 cm.

- Small lymphadenopathy at rt. para tracheal region (0.5-0.6 cm), pre carina region region
(0.5-0.6 cm).

-NO pulmonary nodule.

-Multiple GS.

-Small hypodense at the spleen (0.3cm), likely splenic cyst .

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
ชลประทาน มศว
222 ม.1 ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ติดต่อ: 02-5022345 ต่อ 4108, 4109

HN : 000907875
Name : พชรพล สุขสำราญ
Age : 52 ปี 10 เดือน 6 วัน **Gender :** ชาย
Ref. Unit : 099 ห้อง X-Ray
Study On : 21/11/2025 08:19 **Report On :** 08/12/2025 20:51

Exam Name : CT Neck **Accession No :** 1179504

CT NECK

Male 52 YO, HT , DLP, lt. thyroid nodule R/O malignancy ..

Due to limitation of the study reveals enlargement lt. thyroid gland with huge mixed cystic -solid inhomogeneous hypodense enhancing lesion with calcification at lt. thyroid , size atlest about 7.6 * 6.0 * 5.9 cm.and pressure effected to the trachea and extened to upper thoracic region and superior extension to upper neck abut near inferior aspected lt.submandibular gland and pressure to visualized airway .. .

Multiple nodules at visualized rt. thyroid gland, size upto 0.5 cm.

Visualized rt. and lt. paraotid glands appear intact.

Visualized masticator space, carotid space appear intact .

Visualized nasopharynx, oropharynx and larynx show no abnormal enhancing lesion .

Visualized bilateral submandibular glands are unremarkable.

The cervical ICAs and IJVs are patent.

The visualized brain is unremarkable.

Bilateral orbits appear normal.

Visualized para nasal sinuses appear intact.

Multiple LN at Ia (size about 0.3- 0.5 cm), rt. and lt. Ib (0.5 -1.3 cm), rt. and lt. IIa (0.6- 1.5 cm), rt, and lt. IIb (0.4 - 0.7 cm). rt. and lt.III (0.5 - 0.6 cm)., rt. and lt. IVa (0.4 -0.5 cm).

Degenerative change of bony structure without evidence bony destruction.

IMP; -Male 52 YO, HT , DLP, lt. thyroid nodule R/O malignancy .

-Due to limitation of the study reveals enlargement lt. thyroid gland with huge mixed cystic -solid inhomogeneous hypodense enhancing lesion with calcification at lt. thyroid , size atlest about 7.6 * 6.0 * 5.9 cm.and pressure effected to the trachea and extened to upper thoracic region and superior extension to upper neck abut near inferior aspected lt.submandibular gland and pressure to visualized airway .., tissue study is helpful.

-Multiple nodules at visualized rt. thyroid gland, size upto 0.5 cm.

-Multiple LN at Ia (size about 0.3- 0.5 cm), rt. and lt. Ib (0.5 -1.3 cm), rt.

Exam Name : CT Neck **Accession No :** 1179504

and lt. IIa (0.6- 1.5 cm), rt, and lt. IIb (0.4 - 0.7 cm). rt. and lt.III (0.5 - 0.6 cm)., rt. and lt. IVa
(0.4 -0.5 cm)., please clinical correlation.

HN : 000907875

201690128090054

ใบตรวจรักษาผู้ป่วยนอก (OPD) ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทานวันที่ 28 ม.ค.2569 เวลา 14:28:39

ใบต่อหน้าที่ 1/1

เลขประจำตัว / เลขที่ต่างด้าว : 3-7299-00004-89-1 เลข Passport : 333 ห้องตรวจ 1 หู คอ จมูก

ชื่อ : นายพชรพล สุขสำราญ อายุ 53 ปี 0 เดือน มีโรคประจำตัว HT

สิทธิการรักษา : 51401 ประกันสังคม รพ.ชลประทาน เลขที่สิทธิ3-7299-00004-89-1 สถานพยาบาลหลัก : ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

ประวัติการแพ้ยา : -

ข้อมูลซักประวัติทั่วไป (พยาบาลซักประวัติ : อดิศักดิ์ นับถือบุญ (พว.))

สภาพผู้ป่วย : 1.เดินมา การแพ้ยา : ปฏิเสธการแพ้ LMP:

T. C. P. 100 /min. RR. 20 /min. BP. 125 / 74 mmHg

นน. 77.0 กก. สูง 160.0 ซม. BMI : 30.078 O2Sat :

DTX : mg% เป็นมาแล้ว ความเร่งด่วน : ปกติ

PRE Painscore : 0 ประจำเดือน :

การสูบบุหรี่ : ไม่สูบบุหรี่ การดื่มสุรา : ไม่ดื่ม

ข้อมูลผู้ป่วยห้องฉุกเฉิน

ประเภทผู้ป่วย :

ระดับความเร่งด่วน :

อาการสำคัญ / ประวัติการเจ็บป่วยปัจจุบัน / ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต

CC : มาตามนัดฟังผล FNA ก้อนที่คอเท่าๆเดิม

HPI :

PMH :

การตรวจร่างกาย

วาดรูป/ตรวจเพิ่มเติม

HEENT : :

HEART : :

CHEST : :

Abdoment : :

Ext : :

Neuro : :

บันทึกการตรวจร่างกาย

case large lt. substernal goiter
fna AUS / unsat
u/s lt. thyroid nodule 8cm with TIRADS 5
review CT neck substernal goiter inferior border ชิด aortic arch

plan:
advice risk and benefit of surgery
requires CVT standby for sternotomy (ขณะนี้ PCMC ยังไม่มี CVT surgeon ครับ)
plan refer for Sx

- เตรียม ผล CT, FNA, US ..

- write CD CT neck + US.

Dignosis Note :

Dignosis Text :

การวินิจฉัย

E049 : Nontoxic goitre, unspecified (PDx)

Codemap : THYROID GOITRE, NONTOXIC

คำแนะนำ
☑ การออกกำลังกาย ☑ การปฏิบัติตัวที่เหมาะสมกับโรค ☑ ผิดปกติมาพบแพทย์
☐ การใช้ยา ☐ การมาตรวจตามนัด ☑ การป้องกันภาวะแทรกซ้อน ☑ การรับประทานอาหาร
☐ อื่นๆ :

วันที่นัด นัดเพื่อ
ติดต่อที่ อีก วัน

ผู้ตรวจรักษา (ต้นกล้า พลางกูร (นพ.))
ผู้จ่ายยา

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

DEPARTMENT OF PATHOLOGY
PANYANANTHAPHIKKHU CHONPRATHAN MEDICAL CENTER

222 MOO 1, TIWANON RD, BANG TALAT SUB-DISTRICT,
PAK KRET DISTRICT, NONTHABURI 11120
02-5022345 ext. 4501, 4500

LAB NUMBER
C68-00469

PATIENT'S NAME: นาย พชรพล สุขสำราญ SEX: Male AGE: 52Y 8M 23D
INSTITUTE: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
DEPARTMENT: ENT DOB: 15/1/1973 HN: 000907875 AN: -
NOTE: N/A
CLINICIAN: นพ.ต้นกล้า พลางกูร PATHOLOGIST: Dr.Kritsanu Saetiew
COLLECTION DATE: 08/10/2025 REGISTERED DATE: 08/10/2025 REPORTED DATE: 17/10/2025

TYPE OF SPECIMEN:
Fine needle aspiration

ORGAN:
Thyroid gland

LOCATION:
Left

RECEVIVE AS:
Smeared slides, fixed in 95% alcohol

TECHNIQUE PERFORMED:
Smear 4 slides; PAP stain

ADEQUACY:
Satisfactory for evaluation

CYTOLOGIC DESCRIPTION:
The slides contain a single cluster of atypical follicular cells showing irregular nuclear membrane and pale chromatin. Background of smears reveals few scattered clusters of bland follicular cells.

CYTOLOGIC DIAGNOSIS:
Atypia of Undetermined Significance; nuclear atypia; see Comment
(The Bethesda System for Reporting Thyroid Cytopathology)

☒

Comment: Clinical and imaging correlation is recommended. A repeat aspirate after an appropriate interval (i.e. 3-6 months) of observation might be helpful if clinically indicated.

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

DEPARTMENT OF PATHOLOGY

PANYANANTHAPHIKKHU CHONPRATHAN MEDICAL CENTER

222 MOO 1, TIWANON RD, BANG TALAT SUB-DISTRICT,
PAK KRET DISTRICT, NONTHABURI 11120
02-5022345 ext. 4501, 4500

LAB NUMBER
C68-00469

PATIENT'S NAME: นาย พชรพล สุขสำราญ SEX: Male AGE: 52Y 8M 23D
INSTITUTE: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
DEPARTMENT: ENT DOB: 15/1/1973 HN: 000907875 AN: -
NOTE: N/A
CLINICIAN: นพ.ต้นกล้า พลางกูร PATHOLOGIST: Dr.Kritsanu Saetiew
COLLECTION DATE: 08/10/2025 REGISTERED DATE: 08/10/2025 REPORTED DATE: 17/10/2025

Electronically signed by Dr.Kritsanu Saetiew, Pathologist on 17/10/2025 10:14.

"Reports can be faster accessed via PDviewer application on iOS and Android."

2510171014-2-500

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

DEPARTMENT OF PATHOLOGY

PANYANANTHAPHIKKHU CHONPRATHAN MEDICAL CENTER

222 MOO 1, TIWANON RD, BANG TALAT SUB-DISTRICT,
PAK KRET DISTRICT, NONTHABURI 11120
02-5022345 ext. 4501, 4500

LAB NUMBER
C69-00028

PATIENT'S NAME: นาย พชรพล สุขสำราญ SEX: Male AGE: 52Y 11M 30D
INSTITUTE: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
DEPARTMENT: หู-คอ-จมูก DOB: 15/1/1973 HN: 000907875 AN: -
NOTE: N/A
CLINICIAN: นพ.ต้นกล้า พลางกูร PATHOLOGIST: Dr.Kritsanu Saetiew
COLLECTION DATE: 14/01/2026 REGISTERED DATE: 14/01/2026 REPORTED DATE: 20/01/2026

SUMMARY CLINICAL INFORMATION:
Left thyroid nodule

TYPE OF SPECIMEN:
Fine needle aspiration

ORGAN:
Thyroid gland

LOCATION:
Left

RECEVIVE AS:
Smeared slides, fixed in 95% alcohol

TECHNIQUE PERFORMED:
Smear 4 slides; PAP stain

ADEQUACY:
Unsatisfactory for evaluation

CYTOLOGIC DESCRIPTION:
Hypocellular smears contain rare clusters of bland follicular cells with air-drying artifact in a background of blood components.

CYTOLOGIC DIAGNOSIS:
NON-DIAGNOSTIC
(The Bethesda System for Reporting Thyroid Cytopathology)

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

DEPARTMENT OF PATHOLOGY
PANYANANTHAPHIKKHU CHONPRATHAN MEDICAL CENTER

222 MOO 1, TIWANON RD, BANG TALAT SUB-DISTRICT,
PAK KRET DISTRICT, NONTHABURI 11120
02-5022345 ext. 4501, 4500

LAB NUMBER
C69-00028

PATIENT'S NAME: นาย พชรพล สุขสำราญ SEX: Male AGE: 52Y 11M 30D
INSTITUTE: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
DEPARTMENT: หู-คอ-จมูก DOB: 15/1/1973 HN: 000907875 AN: -
NOTE: N/A
CLINICIAN: นพ.ต้นกล้า พลางกูร PATHOLOGIST: Dr.Kritsanu Saetiew
COLLECTION DATE: 14/01/2026 REGISTERED DATE: 14/01/2026 REPORTED DATE: 20/01/2026

Explanatory note: The Bethesda System for Reporting Thyroid Cytopathology: implied risk of malignancy (ROM) and recommended clinical management

Diagnostic category	Estimated final ROM[5]	Usual management[2]
Nondiagnostic	12	Repeat FNA with ultrasound guidance
Benign	2	Clinical and sonographic follow-up
Atypia of Undetermined Significance	16	Repeat FNA, molecular testing, diagnostic lobectomy, or surveillance
Follicular Neoplasm	23	Molecular testing[3], diagnostic lobectomy
Suspicious for Malignancy	65	Molecular testing[3], diagnostic lobectomy, or near-total thyroidectomy[4]
Malignant	94	Lobectomy or near-total thyroidectomy[4]

[1] Noninvasive Follicular Thyroid Neoplasm with Papillary Like Nuclear Features (NIFTP) cytology. Acta Cytol 2016;60:185–97.
[2] Actual management may depend on other factors (e.g., clinical, sonographic) besides the FNA interpretation.
[3] Molecular analysis can be performed to assess the type of surgical procedure (lobectomy vs. total thyroidectomy).
[4] In the case of "Suspicious for metastatic tumor" or a "Malignant" interpretation indicating metastatic tumor rather than a primary thyroid malignancy surgery may not be indicated.
[5] Estimated final ROM if excluding NIFTP1 (mean %)
Ali SZ, VanderLaan PA, editors. The Bethesda system for reporting thyroid cytopathology: Definitions, criteria, and explanatory notes. 3rd ed. Cham, Switzerland: Springer International Publishing; 2023.

Electronically signed by Dr.Kritsanu Saetiew, Pathologist on 20/01/2026 10:26.